

Tolerancja *dystresu*

Epizod jako reakcja na nietolerowany dyskomfort. DBT skille — TIPP, ACCEPTS, IMPROVE — uczą tolerować emocje BEZ ucieczki. DBT-BN (Safer 2009): redukcja epizodów 50–60% po 20 sesjach.

CZAS: 35 min · psychoedukacja + trening · Etap 2–3 CBT-E · uzupełnienie DBT

ŹRÓDŁO: Linehan (1993, 2015); Safer, Telch & Chen (2009)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **technikę TIPP** — szybką regulację fizjologiczną (sekcja 1), zobacz **ACCEPTS** i **IMPROVE** — dystrakcję i przeformułowanie (sekcja 2). Sekcja 3 — Twój plan kryzysowy. Sekcja 4 — refleksja po użyciu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Intolerancja dystresu to **niska zdolność wytrzymywania trudnych emocji** bez maladaptacyjnej ucieczki. W bulimii: silna emocja → niemożność „po prostu ją poczuć” → **epizod** jako ucieczka. Umiejętności DBT (Linehan 1993, 2015) — moduł *Distress Tolerance* — uczą **tolerować** dyskomfort, nie go **usuwać**. To paradygmatyczna różnica: bulimia jest **strategią usuwania** emocji; DBT uczy **strategii tolerowania**. Kluczowe techniki: **TIPP** (szybka regulacja fizjologiczna), **ACCEPTS** (7 strategii dystrakcji), **IMPROVE** (przeformułowanie). DBT-BN (Safer, Telch & Chen 2009): w RCT redukcja epizodów o **50-60%** po 20 sesjach. Pacjenci z wysoką dysregulacją emocjonalną (komorbidność BPD, traumą, lękiem) szczególnie korzystają z tego modułu.

01 ● TIPP — szybka regulacja fizjologiczna

TIPP to **najszybsza** technika DBT — działa przez *układ nerwowy parasympatyczny*, fizjologicznie obniża aktywację w 5–10 minut. Dla silnego impulsu epizodu jest „narzędziem pierwszego rzutu”.

T · TEMPERATURE

Zimna woda na twarz lub kostka lodu na nadgarstkach. Aktywuje odruch nurkowy → spowolnienie pulsu, spadek aktywacji.

I · INTENSE EXERCISE

Krótkie intensywne ćwiczenie (30 pompek, sprint, skakanka 2 min). **Krótko** — nie kompensacyjnie. Rozładowuje napięcie.

P · PACED BREATHING

Wolne, miarowe oddychanie — wydech dłuższy od wdechu (np. 4 sekundy wdech, 6 sekund wydech). 3–5 minut.

P · PAIRED MUSCLE RELAXATION

Napinanie i rozluźnianie grup mięśni — od stóp do głowy. Trening progresywnej relaksacji Jacobsona.

02 = ACCEPTS & IMPROVE — dystrakcja i przeformułowanie

ACCEPTS — 7 DYSTRAKCJI

- Activities — aktywność (film, książka, gra)
- Contributing — pomoc komuś
- Comparisons — porównanie z trudniejszą sytuacją
- Emotions opposite — przeciwne emocje
- Pushing away — odsunięcie w wyobraźni
- Thoughts — zajęcie umysłu zagadkami
- Sensations — silne bodźce zmysłowe

IMPROVE — PRZEFORMUŁOWANIE

- Imagery — wyobrażenia uspokajające
- Meaning — nadanie sytuacji znaczenia
- Prayer — modlitwa lub kontemplacja
- Relaxation — relaksacja ciała
- One thing — jedno w danej chwili
- Vacation — krótka „ucieczka” (kąpiel, drzemka)
- Encouragement — wspierający dialog wewnętrzny

03 \ Mój plan kryzysowy DBT

Wybierz **3 techniki TIPP** i **3 strategie ACCEPTS/IMPROVE**, które są dla Ciebie najbardziej dostępne. Plan musi być **konkretny i na piśmie** — w kryzysie mózg nie wymyśli strategii od zera.

MOJE 3 TECHNIKI TIPP

— która zimna, co intensywnego, jaki oddech

MOJE 3 STRATEGIE ACCEPTS / IMPROVE

— która aktywność, jakie wsparcie, co konkretnie zrobię

04 \ Refleksja po użyciu techniki

Każde udane użycie DBT skill to *uczenie się*. Po próbie zapisz: co działało, co nie, jak długo trwał impuls, czy udało się przetrwać bez kompensacji.

CO SIĘ SPRAWDZIŁO, CZEGO BRAKOWAŁO

— bez ocen, tylko obserwacja

Klucz: DBT skille uczą tolerować dyskomfort, nie go usuwać. To **paradygmatyczna różnica** w stosunku do bulimii, która jest *strategią usuwania* emocji. Linehan (1993, 2015) opracowała *Distress Tolerance* oryginalnie dla zaburzenia osobowości borderline (BPD), ale moduł okazał się skuteczny w wielu innych zaburzeniach z impulsywnymi zachowaniami — w tym w bulimii. Safer, Telch & Chen (2009) opracowali **DBT-BN** (DBT for Bulimia Nervosa) — specyficzną adaptację z naciskiem na regulację emocji wokół jedzenia. W RCT (Safer i in. 2001, 2010): redukcja epizodów o **50-60%** po 20 sesjach. Mechanizm: pacjent zyskuje *repertuar* alternatywnych strategii regulacji — gdy emocja staje się silna, ma *opcje* inne niż epizod. TIPP jest szczególnie wartościowy, bo działa *fizjologicznie* — przez układ nerwowy parasympatyczny — szybciej niż jakakolwiek strategia poznawcza. ACCEPTS i IMPROVE są wolniejsze, ale uczą *tolerancji* długoterminowej. Integracja z CBT-E: skille są **uzupełnieniem**, nie zastąpieniem pracy jedzeniowej. Pacjenci z wysoką dysregulacją emocjonalną (komorbidność BPD, trauma, lęk) szczególnie korzystają z tego modułu. Bez DBT skille — CBT-E często „*nie sięga*” do emocjonalnego rdzenia bulimii.